

		
NOMBRE: JERÓNIMO CALDERÓN	6 AÑOS	
FECHA DE NACIMIENTO: 27.02.2019	FECHA DE EVALUACIÓN: 41.05.2025	
ESCOLARIDAD: HOWARD GARDNER (TRANSICIÓN)		
DX: AUTISMO EN LA NIÑEZ		
INFORME DE VALORACIÓN		
MAMÁ: YESINA PRENTT (32 AÑOS) OCUPACIÓN: DOCENTE PAPÁ: ÁLVARO CALDERÓN CAICEDO (35 AÑOS) OCUPACIÓN: POLICÍA		

MOTIVO DE CONSULTA
Su madre comenta que “la neuro solicitó que le evaluarán la parte sensorial, ya que rechaza algunos alimentos y texturas, además de presentar conductas agresivas”.

ENTREVISTA
Jero es hijo único vive con sus padres, sus abuelos viven en la casa de abajo. Su mamá comenta que el niño se relaciona muy bien con sus padres y abuelo, su padre juega con él y se lo disfruta. Su mamá muestra preocupación porque muchas veces parece estar tranquilo y se levanta y le pega sobre todo a personas de confianza, sin embargo, también puede hacerlo con desconocidos, esta conducta aumenta cuando se frustra o le dices que “no”, dice que esta conducta se viene presentando desde hace un mes. Cuando le pregunto por la alimentación y me comenta que no come ningún tipo de verduras, sopas o jugos. Su madre agrega que no le gusta estar sucio, comenta que anteriormente era un desafío complejo cortarle el cabello y las uñas, pero en este momento lo permite. Algo que también les llama la atención es su respuesta ante ruidos, suele taparse los oídos, sobre todo cuando escucha a niños llorar. Su mamá hace énfasis en la conducta agresiva, entendiendo que es algo que le preocupa mucho, y agrega que desde hace un mes estas conductas aparecieron

y lo asocia con que en ese lapso de tiempo hubo algunos cambios en la rutina del niño y aspectos emocionales que afectaron a la familia, como la pérdida de una hermana menor recién nacida, interrupción de las terapias y compartía menos con el papá ya que le tocaba cubrir más turnos, y este último es muy importante para el niño, ya que tiene hábitos muy establecidos con su papá, y su mamá comenta que cuando el padre se ausenta mucho este tipo de conductas aumentan.

OBSERVACIONES CLÍNICAS

Las observaciones clínicas son una prueba para recopilar información sobre el procesamiento sensorial, estas pueden hacerse de dos maneras, estructuradas cuando el usuario puede seguir instrucciones y es mayor a los 4 años, y no estructuradas, que se aplican cuando las condiciones anteriores no se tienen. En el caso de Jero elegimos la ruta sin estructura ya que durante los primeros minutos de observación fue muy difícil que siguiera instrucciones y respetara límites.

Jerónimo es un niño que muestra una actividad motora con tendencia alta, no obstante, lo saluda y responde mi saludo, la primera parte de la evaluación consta de una entrevista con la familia, durante este tiempo fue muy difícil para él permanecer tranquilo, en este momento pude notar la conducta de agresividad que manifiesta su madre, esta intentó colocarle límites y Jero la agredió, pero también estando tranquilo reacciona con agresividad siendo imposible anticiparlo.

Jerónimo pide que le coloque música, específicamente de un cantante de vallenato llamado Silvester Dangond, cuando estoy colocando la música me llama la atención que se tapa los oídos, y no es hasta que nota que el volumen es adecuado, que se los destapa, en este momento parece disfrutar la música y hasta baila, mientras escucha música se mantiene tranquilo.

Pasamos al gimnasio para aplicar las observaciones espontáneas tomando en cuenta su interacción con el ambiente, apenas entramos al lugar Jero mostró

RESUMEN DE HALLAZGOS EN VALORACIÓN

MOTRICIDAD GRUESA	Sus habilidades motoras se encuentran conservadas, logra realizar cambios posturales con eficiencia, sin embargo, su principal dificultad está en inhibir el exceso de uso del movimiento, llegando a ser imprudente muchas veces.
MOTRICIDAD FINA	Conserva habilidades de agarre funcionales, tanto digitales como

	palmares, debido a que existe una falla en la modulación del tacto, existen fallas de discriminación que dificultan la manipulación.
NEUROMUSCULAR	Tono Muscular: Bajo tono funcional generalizado. Hiperlaxitud ligamentosa: Si, generalizado. Afecta directamente su tono postural.
INTEGRACIÓN SENSORIAL	Su falla principal es la modulación del tacto y la propiocepción, impactando en su nivel de alerta, por lo cual afecta su conducta. Existen fallas posturales por el inadecuado uso de la propiocepción.
ESTADÍO DE JUEGO	Sensoriomotor.
CONDUCTA	Oposicionista, y en ocasiones agresivo.

CONCLUSIONES
Jerónimo es un niño que muestra una tendencia clara a la búsqueda de sensaciones de movimiento, le cuesta permanecer tranquilo, este estado de actividad alto genera también un estado de alerta alto. El procesamiento sensorial consta de cuatro pasos fundamentales, el registro, la modulación, la discriminación y la praxis, en ese orden específico, y mientras la falla este al principio de ese orden, los siguientes pasos no suceden, explico esto porque la falla de Jero se encuentra en la modulación de las sensaciones táctiles y propioceptivas, las fallas de modulación hacen referencia a la interpretación de la intensidad del estímulo, por lo cual, en el caso del tacto, genera una respuesta exagerada al origen real de la sensación, esto se le conoce como hiper respuesta, esto responde el rechazo que le genera ciertas sensaciones novedosas percibidas a través del tacto, este sistema es muy importante, ya que nos permite interactuar con sensaciones a través de nuestra piel conectadnonos con las texturas de nuestro alrededor, entonces, siendo este un mundo cargado de este tipo de sensaciones las cuales no procesa de manera eficiente, Jero tiende a protegerse o a mantenerse hipervigilante constantemente manteniendo un nivel de alerta alto, los niveles de alerta alto se asocian a problemas conductuales, e incluso agresivos, ya que cuando un cuerpo está sometido a estados de stres este intenta protegerse, por esta razón aparecen este tipo de conductas. Por otra parte, cuando existen este tipo de fallas de modulación táctiles, es común que pueda fallar el sistema propioceptivo, este sistema es el encargado de informar donde y como se

mueve cada parte de mi cuerpo, muy importante para generar destrezas motoras, posturales, autoconcepto entre otras, este sistema es por naturaleza organizador (modulador) con frecuencia recurrimos a él cuando estamos desorganizados, un ejemplo práctico es cuando nos sentimos tristes, un abrazo resulta reconfortante, y el abrazo es presión profunda, sensación que es registrada por la propiocepción. En este sentido, Jero recurre a la propiocepción para intentar modular su sistema del tacto, pero, recurre a ella de manera desorganizada, por lo cual, genera una búsqueda intensa y desordenada de estímulos de alto impacto, que en vez de organizar su nivel de alerta, aumenta su nivel de actividad generando el efecto contrario en la alerta, aumentándola también.

Este desorden se hace extensivo incluso en sistemas como el auditivo, ya que a pesar de que el niño pide escuchar música, se tapa los oídos antes de que suene, y esto se interpreta como la dificultad para modular y por consecuencia discriminar la información auditiva, y esto sucede por el permanente nivel de alerta que presenta Jero.

Dicho todo esto, es importante que el plan de trabajo sea enfocado en primera fase a favorecer la búsqueda e interacción organizada con la propiocepción, utilizar estrategias vestibulares lineales que co-ayuden a la propiocepción, esto permitirá facilitar un sistema nervioso modulado que ayudará a procesar e interactuar con mayor eficiencia con sensaciones del tacto.

En segunda fase, favorecer la interacción con sensaciones táctiles novedosas, apoyándonos del tacto profundo, tacto no discriminativo y vestibular lineal. Entiendo que quizás estos conceptos parezcan algo confuso, sin embargo, este documento es dirigido para la familia, y para la terapeuta ocupacional que aplicará el plan de trabajo, por lo cual, estas últimas líneas van dirigidas a ella y a otros especialistas.



Germán Burguillos
Terapeuta Ocupacional
Certificado en Integración Sensorial USC #3558